NEURO · NE-01

# AVC ischémique aigu

**AHA/ASA 2026**

imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

## IMAGERIE INITIALE · « LE TEMPS, C'EST DU CERVEAU »

**1 · Parenchyme**
Scanner sans injection ou IRM (diffusion, FLAIR, T2*) : exclure une hémorragie, évaluer l'infarctus constitué (ASPECTS)

›

**2 · Vaisseaux**
Angioscanner ou ARM de la crosse aortique au vertex si thrombectomie possible : occlusion d'un gros vaisseau (ACI, M1, M2, tronc basilaire)

›

**3 · Perfusion (sélectif)**
Scanner ou IRM de perfusion : 6–24 h, heure de début inconnue, viabilité incertaine. Ne doit pas retarder le traitement

**Ne pas retarder :** l'imagerie vasculaire ne doit pas attendre la **créatinine** (COR 1, AHA/ASA 2026).

**Réveil ou heure inconnue :** en IRM, un **mismatch diffusion–FLAIR** (lésion visible en diffusion, pas encore en FLAIR) suggère un début < 4,5 h et permet une thrombolyse chez des patients sélectionnés.

## ASPECTS (TERRITOIRE DE L'ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE)

Partir de **10** et retirer **1 point par région** présentant une hypodensité ou une perte de différenciation précoce.

| NIVEAU | 10 RÉGIONS |
|---|---|
| Noyaux gris (coupe thalamo-striée) | C (caudé), L (lenticulaire), IC (capsule interne), I (insula), M1, M2, M3 |
| Supra-ganglionnaire | M4, M5, M6 |

PC-ASPECTS (circulation postérieure) : 10 points, thalamus 1 chacun, lobe occipital 1 chacun, mésencéphale 2, pont 2, cervelet 1 chacun.

### Interprétation

| ASPECTS | SIGNIFICATION |
|---|---|
| 6–10 | Infarctus constitué limité |
| 3–5 | « Large core » : thrombectomie désormais recommandée dans des cas sélectionnés |
| 0–2 | Infarctus étendu : thrombectomie seulement dans des cas très sélectionnés |

Lecture en fenêtre étroite (W ≈ 40, L ≈ 40), sur coupes fines ou reconstructions.

## THROMBECTOMIE · CIRCULATION ANTÉRIEURE (ACI OU M1)

| DÉLAI | CRITÈRES | RECOMMANDATION AHA/ASA 2026 |
|---|---|---|
| **0–6 h** | NIHSS ≥ 6, mRS préalable 0–1, **ASPECTS 3–10** | **Recommandée** (nouveau, fort impact) ; ASPECTS 0–2 : raisonnable chez des patients sélectionnés |
| **6–24 h** | NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS ≥ 6** | **Recommandée** |
| **6–24 h** | Âge < 80 ans, NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS 3–5**, pas d'effet de masse significatif | **Recommandée** chez des patients sélectionnés (nouveau) |
| **0–6 h** | NIHSS ≥ 6, **ASPECTS ≥ 6**, **mRS préalable 2** | **Raisonnable** (2a, nouveau) pour réduire le handicap cumulé |

### Tronc basilaire

- Thrombectomie recommandée jusqu'à **24 h** si mRS 0–1, **NIHSS ≥ 10** et **PC-ASPECTS ≥ 6**
- NIHSS 6–9 : bénéfice incertain

### Thrombolyse IV

- Dans les **4,5 h** si pas d'hémorragie : **altéplase 0,9 mg/kg** ou **ténectéplase 0,25 mg/kg (max 25 mg)** (COR 1)
- **4,5–9 h ou réveil** (début ≤ 9 h du milieu du sommeil) : raisonnable (2a) si **pénombre sur perfusion automatisée** — voir NE-04
- Si thrombectomie prévue : ne pas retarder la thrombolyse ni attendre la réponse clinique

## COMPTE RENDU : À DONNER EN PREMIER

**Hémorragie ?**
oui / non, en premier

**Occlusion**
site exact (ACI, M1, M2, tronc basilaire), tandem, dissection

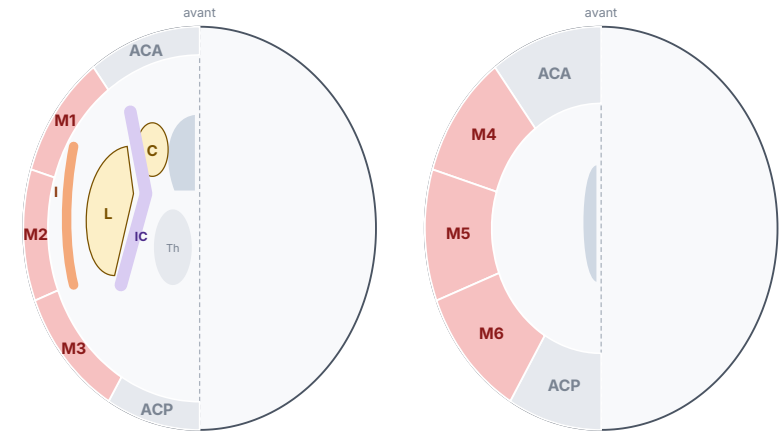
**Infarctus constitué**
ASPECTS, volume du cœur ischémique et mismatch si perfusion

**Voie d'abord**
crosse, tortuosités, sténose cervicale

# AVC ischémique aigu (suite)



## ATLAS VISUEL · LES 10 RÉGIONS ASPECTS




Niveau des noyaux gris (thalamo-striatal) — Niveau supra-ganglionnaire

Schéma simplifié, non à l'échelle · hémisphère droit du patient à gauche de l'image (convention radiologique)

### Comment coter

- Lire sur **2 niveaux** : noyaux gris (thalamus, striatum) et supra-ganglionnaire, juste au-dessus des noyaux
- **Structures profondes** C caudé, L lenticulaire, IC capsule interne (3 points)
- **I** ruban insulaire (1 point)
- **Cortex** M1–M3 au niveau des noyaux, M4–M6 au-dessus (6 points)
- Retirer 1 point par région avec hypodensité ou perte de différenciation substance grise / blanche
- Les territoires ACA et ACP (gris) ne sont pas cotés

ASTUCE

Toute la région doit être examinée sur plusieurs coupes ; une atteinte partielle suffit à retirer le point.

## SIGNES PRÉCOCES À RECONNAÎTRE

### ACM hyperdense

Segment M1 ou M2 spontanément plus dense que le côté opposé (thrombus). Comparer à l'ACM controlatérale.

Voir un cas ↗

### Ruban insulaire

Perte de la différenciation cortex / substance blanche de l'insula, l'un des signes les plus précoces.

Voir l'article ↗

### Noyau lenticulaire

Effacement des contours du noyau lenticulaire, hypodensité des noyaux gris (atteinte des perforantes).

Voir des exemples ↗

### Mismatch diffusion–FLAIR

Lésion visible en diffusion mais pas encore en FLAIR : début probable < 4,5 h.

Voir un cas ↗

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**ASPECTS : article et images**
Radiopaedia · régions, exemples annotés, PC-ASPECTS
radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programm

**Calculateur ASPECTS**
MDCalc · cocher les régions atteintes
www.mdcalc.com/calc/3164/alberta-stroke-program-

**Signe de l'ACM hyperdense (cas)**
Radiopaedia · thrombus spontanément dense
radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-16

**Perte du ruban insulaire**
Radiopaedia · signe précoce au scanner
radiopaedia.org/articles/loss-of-the-insular-rib

**Mismatch diffusion–FLAIR (cas)**
Radiopaedia · infarctus hyperaigu, AVC du réveil
radiopaedia.org/cases/hyperacute-mca-infarct-wit

**PC-ASPECTS illustré**
Radiopaedia · circulation postérieure
radiopaedia.org/cases/posterior-circulation-acut

**Sources :** AHA/ASA 2026 – Early Management of AIS (Stroke, texte intégral) – www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000513 · StatPearls – Acute Stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · Radiopaedia – ASPECTS – radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programme-early-ct-s...